Centre hospitalier du Val-de-Brenne
Pôle cardio-vasculaire · Service de cardiologie
12 avenue des Tilleuls · 37290 Brenne-sur-Loir

Secrétariat : 02 47 91 30 40
Chef de service : Dr Hélène Marchais

Compte rendu d'hospitalisation

Patient	M. Laurent PICHON, né le 03/02/1958 (68 ans)
Entrée	Le 06/10/2026 par les urgences
Sortie	Le 13/10/2026 vers le domicile
Médecin traitant	Dr Arnaud Lemoine, Brenne-sur-Loir

Motif d'hospitalisation

Le patient a été admis pour une dyspnée d'effort d'aggravation progressive, associée à des œdèmes des membres inférieurs. Il décrivait une prise de poids de quatre kilogrammes en dix jours.

Antécédents

- Hypertension artérielle traitée depuis 2011
- Diabète de type 2
  - sous metformine depuis 2016
  - dernière HbA1c à 7,4 %
- Tabagisme sevré en 2019, estimé à 30 paquets-années
- Pas d'allergie médicamenteuse connue

Histoire de la maladie

À l'arrivée, la pression artérielle était de 152/88 mmHg et la saturation en oxygène de 91 % en air ambiant. L'auscultation retrouvait des crépitants aux deux bases pulmonaires. L'électrocardiogramme montrait une fibrillation atriale à 118 battements par minute, sans trouble de la repolarisation.

Examens complémentaires

Biologie

Paramètre	Résultat	Unité	Valeurs de référence
NT-proBNP	**4 860**	pg/mL	< 300
Créatinine	112	µmol/L	64 – 104
Débit de filtration glomérulaire	58	mL/min/1,73 m²	> 90
Potassium	4,3	mmol/L	3,5 – 5,0
Hémoglobine	13,1	g/dL	13,0 – 17,0
Troponine T hypersensible	18	ng/L	< 14

Imagerie

L'échocardiographie transthoracique a mis en évidence une fraction d'éjection du ventricule gauche estimée à 38 %, avec une hypokinésie globale. La radiographie thoracique objectivait un épanchement pleural droit de faible abondance.

Évolution

L'évolution a été favorable sous diurétiques par voie intraveineuse, avec une perte de poids de 3,8 kg. Le rythme a été contrôlé par un bêtabloquant, et une anticoagulation orale a été introduite après évaluation du risque hémorragique. Le patient a bénéficié d'une séance d'éducation thérapeutique sur la surveillance du poids et la restriction sodée.

Traitement de sortie

Médicament	Posologie	Durée
Furosémide 40 mg *comprimé sécable*	1 comprimé le matin	À réévaluer à 15 jours
Bisoprolol 2,5 mg *comprimé pelliculé*	1 comprimé matin et soir	Au long cours
Apixaban 5 mg *comprimé pelliculé*	1 comprimé matin et soir	Au long cours
Ramipril 2,5 mg *gélule*	1 gélule le soir	Au long cours
Metformine 850 mg *comprimé*	1 comprimé matin et soir, au repas	Inchangé

Consignes et suivi

- Peser le patient chaque matin et consulter en cas de prise de plus de 2 kg en trois jours
- Rendez-vous programmés
  - consultation de cardiologie le 10/11/2026 à 9 h 30
  - bilan sanguin avec ionogramme et créatinine sous huit jours
- Régime pauvre en sel, limité à 6 g par jour
- Reprise progressive de la marche, sans effort violent pendant un mois

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Veuillez agréer, cher confrère, l'expression de nos sentiments confraternels.

Brenne-sur-Loir, le 13 octobre 2026 Dr Julien Ferrand, praticien hospitalier